EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 79998
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-03-04 09:45:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: DOMINGO ANTONIO MENDEZ MENDEZ			RUN	: 7.928.523-4
F.Nac	: 16-02-1956	Edad	: 68 AÑOS	Género	: Masculino
Dirección	: TIUQUILEMU			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 86968385		
Fecha Ingreso	: 2024-02-27	Fecha Egreso	: 2024-03-04 09:45:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.9-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Insuficiencia respiratoria aguda:
-Neumonía multilobar
ITU:
-Enterococcus faecium (Resistencia: Van A - BLEE)
-Candida albicans
THE: Hipokalemia, hiponatremia
Sx Convulsivo secundario a Encefalopatía metabólica (hiponatremia + hipoxemia)
UPP sacra, trocantérea Izq, glútea D°

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente, con antecedentes mencionados, con egreso reciente 48hrs previas, reingresa el dia 26/2/24 traído por SAMU por compromiso del estado general y dificultad para respirar, ingresando a REA HSC con crisis convulsiva tónico clónica generalizada, con desviación de la mirada a la derecha , autolimitada según describe el personal de urgencias en el DAU; con apoyo de MAF a 15 litros
Antígeno COVID negativo; PCR 228 NA 126; Rx de tórax con imagen de consolidación en base izquierda PH 7.38 PCO2 43 PO2 77.5 HCO3 26.1 fio2 100%
Ingresa a servicio; vigil, orientado en persona, normosaturando ambiental, Hemodinámicamente estable
Cardiopulmonar: MP disminuido en hemitórax izquierdo, con roncus y crepitantes bilaterales, RsCsRs NAS
Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación . RH +
Extremidades: sin edema , ni signos de TVP
Neurológico: vigil, orientación poco evaluable, disartria severa hipokinetica, fascie hipomimica, paraparesia espástica secuelar , rigidez en extremidades superiores, con temblor en reposo (en su basa
Durante estancia, paciente en regulares a buenas condiciones generales, sin requerimiento de oxígeno. Se recibe TC de Tx que reporta neumonía multilobar. CSB positivo para cándida (tomado posterior a inicio de ceftriaxona, probablemente con sensibilidad acorde en vista de disminución de parámetros), UCT positivo para e faecium poliresistente, sensible a lineozlid.
En vista de condiciones, se decide alta médica con HODOM

INDICACIONES AL ALTA

1. DERIVO A HODOM
2. Reposo semisentado 30°

3. Regimen papilla a tolerancia
4. Ceftriaxona 2 gr al dia EV (7/10)
5. Linezolid 600mg vo c12h (3/10)
6. Bromuro de ipratropio 4 puff c/6hrs por AC
7. Salbutamol 2 puff c/8hrs por AC y SOS
8. Omeprazol 20 mg al dia VO
9. Levodopa/carbidopa 250/25, 1/4 comp 8:00-10:30-13:00-15:30-18:00-20:30 VO
10. Pramipexol 1/2 comp 8:00-13:00-18:00 VO
11. Sertralina 50 mg al dia VO
12. Slow K 2 comp vo c8h
13. Tonaril 1/2 comp 8:00-15:30 hrs
14. HGT precomidas + IC segune squema
15. Paciente LET; no tubo, no UPC, no reanimar
16. KNT respiratoria y motora una vez al día
17. Examenes de control 06/03

andres david velasquez guerra MEDICO TRATANTE 27124399-5	JEFE SERVICIO